Клинические рекомендации

Хронический ринит

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J30.0** — Вазомоторный ринит **J31.0** — Хронический ринит **J34.3** — Гипертрофия носовой раковины
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 06.10.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Национальная ассоциация ринохирургов
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/1082_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Фенотипы 3

2.3 Этиология 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 6

3.1 Жалобы, анамнез и осмотр 7

3.2 Цитологическое исследование мазка из носа 8

3.3 Посев отделяемого из носа 8

3.4 Эндоскопия полости носа и носоглотки 8

3.5 КТ или конусно-лучевая томография пазух 8

3.6 Консультации специалистов 8

4. Лечение 9

4.1 Базисная терапия 9

4.2 Вазомоторный ринит 9

4.3 Обострение и медикаментозный ринит 10

4.4 Атрофический и хронический катаральный ринит 10

4.5 Хирургическое лечение 10

4.6 Лечение после вмешательства на нижних носовых раковинах 11

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 12

5.1 Показания к госпитализации 12

5.2 Профилактика 12

6. Источник и актуальность **12**

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Хронический ринит (ХР): воспаление слизистой носа с двумя и более симптомами — заложенность, выделения, чихание, зуд — **не менее 1 часа** ежедневно **не менее 12 недель** в год. Кроме атрофического, это «диагноз второй очереди»: он устанавливается после исключения инфекционной и аллергической природы ринита.
- Лечение: устранить причину и триггеры, промывания солевыми растворами. Вазомоторный ринит: назальные кортикостероиды или азеластин **с 12 лет**. Медикаментозный ринит: постепенная отмена деконгестанта на фоне других средств.
- Деконгестанты — **не более 7 дней**, при хронических заболеваниях носа и пазух лучше **не более 3 дней**.
- Операция — симптоматическое лечение: при неэффективности адекватной терапии **6–12 месяцев** или при гипертрофическом рините. Турбинэктомия (радикальная конхотомия) не рекомендуется, кроме тяжёлых форм первичного атрофического ринита.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Хронический ринит: любое воспаление слизистой оболочки носа с двумя и более симптомами — заложенность, ринорея, чихание, зуд в носу — **не менее 1 часа** ежедневно **не менее 12 недель** в год. Обычно так называют все хронические риниты, кроме аллергического (неаллергический ринит).

2.2 Фенотипы

Фенотипы хронического ринита

Фенотип	Определение
Вазомоторный (идиопатический) ринит, неаллергическая ринопатия	самый частый фенотип; диагноз после исключения инфекции, аллергии и других форм ХР; в основе — нарушение нервно-рефлекторной регуляции микроциркуляции слизистой
Гипертрофический ринит (гипертрофия нижних носовых раковин)	необратимое увеличение нижних раковин как проявление ХР, реже за счёт костной основы; стойкое затруднение носового дыхания
Гормональный ринит	при гипотиреозе или изменении уровня половых гормонов: беременность, менопауза, фазы цикла, пубертат
Ринит беременных (гестационный)	стойкая заложенность, возникшая во время беременности (чаще во II–III триместре), 6 недель и более, без инфекции и аллергии, проходит за 2 недели после родов
Лекарственно-индуцированный ринит	изменения слизистой от системных и назальных лекарственных препаратов
Медикаментозный ринит	самый частый лекарственно-индуцированный: длительное применение назальных деконгестантов
Профессиональный ринит	назальные симптомы, связанные с рабочей средой; неаллергический — от низкомолекулярных раздражителей (менее 5 кДа), высокомолекулярные чаще вызывают аллергический
Ринит курильщика	разновидность профессионального: раздражитель — табачный дым

Фенотип	Определение
Вкусовой ринит	водянистая ринорея на острую пищу или алкоголь, без чихания, зуда, кожных симптомов и бронхообструкции
Ринит пожилых (старческий)	старше 65 лет; водянистая ринорея, усиливается от триггеров; иногда сухость и корки
Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (NARES)	эозинофильное воспаление слизистой при отрицательных аллергопробах
Атрофический ринит	атрофия слизистой: заложенность, сухость, корки, носовые кровотечения; первичный и вторичный
Хронический катаральный ринит	по морфологической классификации Л. Б. Дайняка (1966): постоянное негнойное воспаление; используется при смешанных фенотипах

По течению

1. интермиттирующий: симптомы **менее 4 дней** в неделю или **менее 4 недель** в году;
2. персистирующий: **более 4 дней** в неделю и **более 4 недель** в году.

По тяжести

1. лёгкая: слабые симптомы, не нарушают дневную активность и сон;
2. средняя: мешают работе, учёбе, спорту, нарушают сон;
3. тяжёлая: значительно ухудшают качество жизни, без лечения нормальная жизнь невозможна, значительно нарушен сон.

У взрослых и подростков — 10-балльная ВАШ: **менее 5 баллов** — лёгкое течение, **5 и более** — среднетяжёлое или тяжёлое. Около 20% пациентов — смешанные или неклассифицируемые формы.

2.3 Этиология

Выделяют воспалительный эндотип (воспаление слизистой) и нейрогенный (нарушение вегетативной регуляции тонуса сосудов и секреции).

Общее для всех форм, кроме атрофического, — гиперреактивность слизистой к неспецифическим триггерам, слабее, чем при аллергическом рините.

Препараты, вызывающие лекарственно-индуцированный ринит

Группа препаратов	Препараты
Нестероидные противовоспалительные (M01A)	диклофенак, кеторолак, целекоксиб
Альфа-адреноблокаторы (G04CA, C02CA)	алфузозин, доксазозин, силодозин, тамсулозин
Антиадренергические центрального действия (C02A)	клонидин, метилдопа
Агонисты дофаминовых рецепторов (N04BC)	пирибедил
Бета-адреноблокаторы (C07A)	атенолол, бисопролол, карведилол, метопролол, пропранолол

Группа препаратов	Препараты
Противоопухолевые (L01)	анагрелид
Антитромботические (B01)	цилостазол, дипиридамол
Для лечения эректильной дисфункции (G04BE)	силденафил, тадалафил, варденафил
Ингибиторы АПФ (C09A)	каптоприл, эналаприл, лизиноприл, рамиприл
Психолептики (N05) и психоаналептики (N06)	алпразолам, амитриптилин, хлорпромазин, миансерин, рисперидон, тиоридазин; гинкго билоба листья
Ингибиторы кальциневрина (L04AD)	циклоспорин
Эстрогены (G03C)	—
Диуретики (C03)	гидрохлоротиазид
Противоэпилептические (N03A)	габапентин

Вещества, вызывающие профессиональный ринит

Вещество	Профессия, категория населения
Высокомолекулярные (более 5 кДа), аллергический ринит: зерновая мука; эпидермис животных; латекс	пекари, пищевая промышленность; лаборатории, животноводство, скотобойни, ветеринары; медработники, лаборатории, клининг
Низкомолекулярные (менее 5 кДа), неаллергический ринит: персульфаты; древесная пыль; формальдегиды; выхлопные газы; бензол, толуол; тальк; аммиак, растворители; табачный дым	парикмахеры; столяры, деревообработка; строители, химпром, лаборатории, морги; автомеханики, дорожные рабочие, жители мегаполисов; маляры; косметическая промышленность, лаборатории, медработники; химпром, лаборатории; курящие и их окружение

Первичный атрофический ринит обычно у людей старше 50 лет, чаще у отдельных этнических групп (юг Азии, Африка); вторично присоединяется Klebsiella ozaenae. Вторичный атрофический ринит развивается чаще после ринохирургии (прежде всего на нижних раковинах), реже от назальных препаратов, лучевой терапии, при гранулематозе с полиангиитом.

2.4 Клиническая картина

Выраженность симптомов по фенотипам

Фенотип	Заложенность	Ринорея	Зуд, чихание	Гипосмия
Старческий	++	+++	+	++
Профессиональный	++	+	++	+

Фенотип	Заложенность	Ринорея	Зуд, чихание	Гипосмия
Медикаментозный, лекарственно-индуцированный	+++	+	+	+
Гормональный	++	++	+	+
Вкусовой	++	+++	+	+
Вазомоторный	++	++	++	++
NARES	++	++	+	+++

Патогномоничных симптомов нет.

Общие симптомы, кроме атрофического ринита

1. заложенность носа;
2. передняя и задняя ринорея;
3. чихание, зуд;
4. гипосмия.

Глазных симптомов, в отличие от аллергического ринита, нет; триггеры действуют слабее.

Течение

1. постоянные симптомы: старческий ринит, NARES, медикаментозный, тяжёлый профессиональный;
2. только при воздействии причины: лёгкий профессиональный, вкусовой;
3. волнообразное: вазомоторный и гормональный;
4. лекарственно-индуцированный: зависит от схемы и длительности приёма препарата.

Атрофический ринит

1. сухость и раздражение в носу, корки, носовые кровотечения;
2. заложенность и снижение обоняния;
3. при тяжёлом течении — полное отсутствие носового дыхания, не восстанавливающееся после деконгестантов, и аносмия.

Наиболее тяжело протекают первичный атрофический ринит и вторичный, связанный с системными аутоиммунными гранулематозными полиангиитами: поражаются хрящевые и костные структуры вплоть до перфорации перегородки носа, изменения формы наружного носа и секвестрации раковин.

Первичный атрофический ринит у детей встречается крайне редко; вторичный у детей бывает чаще первичного, но реже, чем у взрослых.

---

3. Диагностика

Чётких общих критериев нет. Формула фенотипа: периодические или постоянные симптомы ринита + связь с определённым внешним или внутренним фактором (после исключения инфекции и аллергии).

Смешанные формы ринитов существуют: признаки инфекции или аллергии не исключают у пациента фенотип ХР.

Критерии диагноза по фенотипам

Фенотип	Критерии диагноза
Ринит беременных	1. заложенность носа, которой не было до беременности; 2. симптомы 6 недель и более; 3. исключены аллергия и инфекция; 4. полное разрешение за 2 недели после родов (ретроспективно).
Медикаментозный	1. регулярное ежедневное применение назальных сосудосуживающих вне простуд для улучшения дыхания.
Лекарственно-индуцированный	1. симптомы (прежде всего заложенность) вне простуд на фоне некоторых классов препаратов, проходят по окончании их действия.
Профессиональный	1. симптомы на рабочем месте или их усиление на работе; 2. уменьшаются или проходят вне работы; 3. исключён аллергический ринит.
Ринит пожилых	1. постоянные (чаще слизистые) выделения или стекание по задней стенке глотки; 2. старше 65 лет; 3. исключены аллергия и другие причины ринореи.
Вкусовой	1. симптомы на пряную пищу, проходят после её прекращения; 2. исключён аллергический ринит; 3. нет симптомов в начале приёма пищи.
NARES	1. эозинофилы более 25% в цитологии мазка со слизистой носа; 2. исключён аллергический ринит; 3. персистирующие симптомы с выраженным нарушением обоняния.
Вазомоторный	1. периодические или постоянные симптомы без связи с внешними и внутренними факторами; у взрослых чаще попеременная заложенность половин носа, заложенность на стороне, на которой лежит; 2. исключён аллергический ринит; 3. исключены другие причины по осмотру оториноларинголога.
Гормональный	1. общепринятых критериев нет: подтверждённый гипотиреоз или акромегалия с персистирующими симптомами, либо симптомы при менструации, в пубертате — после исключения других причин.
Атрофический	1. признаки атрофии: корки, сухость слизистой; 2. ощущение сухости, заложенность, нарушение обоняния или неприятный запах выделений; 3. и (или) периодические носовые кровотечения.

3.1 Жалобы, анамнез и осмотр

Уточняют

1. длительность, что спровоцировало начало, динамику жалоб, влияние на сон и активность;
2. лечение и его эффект, нежелательные явления;
3. симптомы вне эпизодов ОРИ;
4. сопутствующие заболевания, прежде всего аллергию;
5. ринохирургические вмешательства и манипуляции в носу.

Всем пациентам с ХР показан первичный осмотр оториноларинголога.

3.2 Цитологическое исследование мазка из носа

Показания

1. подростки и взрослые с персистирующими симптомами и выраженным нарушением обоняния при исключённом аллергическом рините: подтверждение или исключение NARES.

Для остальных фенотипов рутинно не проводят: низкие чувствительность и специфичность.

3.3 Посев отделяемого из носа

Показания

1. признаки первичного атрофического ринита: выявление Klebsiella ozaenae.

3.4 Эндоскопия полости носа и носоглотки

Показания

1. стойкая выраженная одно- или двусторонняя назальная обструкция: оценка полости носа и дифференциальная диагностика.

3.5 КТ или конусно-лучевая томография пазух

Показания

1. подозрение на сопутствующий хронический риносинусит.

Конусно-лучевая томография — вариант КТ с меньшей лучевой нагрузкой.

3.6 Консультации специалистов

Показания к консультации аллерголога-иммунолога

1. все фенотипы, кроме атрофического ринита: подтверждение или исключение аллергического ринита.

При аллергическом рините сопутствующий фенотип ХР выделяют, если сенсибилизация не объясняет течение (например, круглый год при сенсибилизации только к пыльце) или нет контроля при максимальном лечении.

Показания к консультации эндокринолога

1. взрослые с ХР без диагностированной эндокринной патологии, но с признаками гипотиреоза.

Признаки гипотиреоза

1. утомляемость, сонливость;
2. сухость кожи, выпадение волос;
3. замедленная речь, охриплость;
4. отёчность лица, пальцев;
5. запоры, зябкость, снижение памяти, подавленность.

Показания к консультации детского эндокринолога

1. дети с ХР после исключения аллергического и медикаментозного ринита, с признаками врождённого гипотиреоза;
2. девочки пубертатного возраста с ХР после исключения аденоидов, аденоидита, аллергического и медикаментозного ринита.

Показания к консультации профпатолога

1. взрослые с подозрением на профессиональный ринит: установление связи с производственной средой.

4. Лечение

Ключевым направлением лечения является устранение или минимизация влияния причинного фактора, если его удаётся установить.

За исключением гипертрофической формы хронический ринит изначально не требует операции, а необоснованное вмешательство нередко вредит. Операция остаётся лишь симптоматическим методом: она может улучшить носовое дыхание, но почти не влияет на ринорею, чихание, зуд и обоняние.

Все формы хронического ринита, кроме некоторых видов атрофического, не угрожают жизни и не создают высокого риска тяжёлых осложнений. Поэтому консервативное лечение проводят планово и амбулаторно, а операцию выполняют планово в условиях стационара.

4.1 Базисная терапия

Показания к лечебно-оздоровительному режиму

1. всем пациентам — ограничение причинных факторов и триггеров.

Триггеры

1. табачный дым и пар электронных сигарет;
2. перепады температуры, запылённость, резкие запахи;
3. пряности, алкоголь;
4. нарушение сна, гиподинамия, стресс.

Показания к ирригационной терапии

1. все фенотипы хронического ринита, в том числе ринит беременных: промывание или орошение носа морской водой, стерильными солевыми растворами.

Способ, кратность, изо- или гипертонический раствор и длительность выбирает врач по фенотипу и течению.

4.2 Вазомоторный ринит

Показания к назальным кортикостероидам

1. вазомоторный ринит у пациентов **старше 12 лет**.

Дозы

1. беклометазон: 200–400 мкг в сутки, курс **не более 3 месяцев**;
2. #мометазон: 200 мкг 1 раз в день, **6 недель**;
3. #флутиказон: 200 мкг 1 раз в день, **3 месяца**.

Минимальная эффективная доза; предупредить о носовых кровотечениях. Не применять при атрофии слизистой, в том числе при атрофическом рините.

Азеластин назально назначают курсом **2–3 недели** пациентам **старше 12 лет** с вазомоторным ринитом. Данных о пользе более длительного курса нет.

Показания к фиксированным комбинациям

1. смешанные фенотипы с сопутствующим аллергическим ринитом.

Препараты и возрастные ограничения

1. азеластин + флутиказон, мометазон + олопатадин: **старше 12 лет**;
2. азеластин + мометазон: **старше 18 лет**.

4.3 Обострение и медикаментозный ринит

При обострении с выраженной заложенностью назначают оксиметазолин коротким курсом **до 7 дней**. Деконгестанты уменьшают только заложенность. Предпочтительны назальные препараты без антисептиков-консервантов.

Показания к сочетанию оксиметазолина с #мометазоном

1. взрослые, которым деконгестант нужен дольше недели при обострении ХР или острой инфекции носа с выраженной заложенностью.

Схема

1. оксиметазолин спрей вместе с #мометазоном 100–200 мкг в сутки, **15–20 дней**.

Медикаментозный ринит: деконгестант отменяют постепенно, сначала уменьшая кратность и разовую дозу, одновременно назначают морскую воду, назальные кортикостероиды, противоаллергические средства. Требование одномоментной отмены часто не выполняется.

4.4 Атрофический и хронический катаральный ринит

При атрофическом рините назначают увлажняющие средства на основе натрия гиалуроната.

При тяжёлом первичном атрофическом рините с выделением Klebsiella ozaenae назначают системные антибиотики с учётом чувствительности возбудителя.

Пациентам **старше 18 лет** с хроническим катаральным ринитом и гнойным отделяемым назначают фрамицетин.

Пациентам **старше 18 лет** с хроническим катаральным ринитом и вязким секретом назначают назальный спрей ацетилцистеин + туаминогептан.

Пациентам с вазомоторным, медикаментозным или лёгким атрофическим ринитом, приверженным такому лечению, возможно назначение гомеопатических средств, зарегистрированных в России как лекарственные препараты, по показаниям инструкции.

При вазомоторном или медикаментозном рините с ограничениями медикаментозного лечения показана консультация физиотерапевта.

4.5 Хирургическое лечение

Хирургическое лечение по фенотипам

1. при гипертрофическом рините операция проводится всем пациентам;
2. при вазомоторном, медикаментозном рините и NARES — при наличии обоснования, при старческом, профессиональном и атрофическом — в редких случаях;
3. при гормональном, гестационном, вкусовом и лекарственно-индуцированном рините данных о пользе хирургического лечения нет.

Показание

1. адекватное лечение **6–12 месяцев** не улучшило качество жизни или операция может значительно его улучшить.

Принцип минимальной травматизации слизистой; пациента предупреждают о возможной нестойкости результата и повторных вмешательствах.

Показания к подслизистой вазотомии или пластике нижних носовых раковин

1. гипертрофический, вазомоторный, медикаментозный ринит или NARES, рефрактерные к лечению.

Вмешательство выполняют под эндоскопическим контролем.

У дошкольников и младших школьников чаще консервативный подход; у детей все манипуляции на раковинах — только в подслизистом слое.

Варианты: передняя и (или) задняя конхотомия, пластика раковин, подслизистая вазотомия, в том числе с латерализацией костной части; лазерные технологии. Сохранение слизистой уменьшает нарушения мукоцилиарного клиренса, синехии и корки.

Показания к селективной нейрэктомии нижней задней носовой ветви большого нёбного нерва

1. тяжёлое, медикаментозно неконтролируемое течение.

При выраженной заложенности нейрэктомию сочетают с операцией на раковинах. При атрофическом рините она не показана.

Показания к остеоконхотомии

1. гипертрофический ринит с увеличенным костным остовом нижней раковины.

Турбинэктомия (радикальная конхотомия) не рекомендуется, кроме тяжёлого первичного атрофического ринита.

Последствия турбинэктомии

1. нарушение воздушного потока;
2. корки, инфицирование;
3. риск синдрома «пустого носа».

Показания к резекции поражённых структур латеральной стенки по типу секвестрэктомии

1. тяжёлый первичный атрофический ринит.

Вмешательство паллиативное, облегчает уход.

Показания к пластике нижних раковин по типу аугментации нижнего носового хода

1. тяжёлый ятрогенный атрофический ринит с синдромом «пустого носа».

4.6 Лечение после вмешательства на нижних носовых раковинах

1. ранний и поздний послеоперационный период: промывание или орошение изотонической морской водой, солевыми растворами;
2. взрослые с тяжёлым первичным атрофическим ринитом после хирургического лечения: системные антибиотики.

При субатрофических проявлениях после операции на раковинах назначают увлажняющие средства с натрия гиалуронатом: они облегчают туалет носа и ускоряют восстановление слизистой оболочки.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Диагностика и консервативное лечение проводятся амбулаторно, плановое хирургическое лечение — в стационаре.

Показания к плановой госпитализации для операции

1. вазомоторный и медикаментозный ринит (реже тяжёлый NARES, гормональный, профессиональный, сенильный) без эффекта адекватного лечения **6–12 месяцев**;
2. гипертрофический ринит с увеличенным костным остовом, постоянной выраженной заложенностью и значительным снижением качества жизни;
3. тяжёлый первичный атрофический ринит;
4. тяжёлый ятрогенный атрофический ринит с синдромом «пустого носа».

Выписка

1. хирургическое лечение выполнено в необходимом объёме;
2. удовлетворительное состояние, нет острого инфекционного воспаления.

5.2 Профилактика

Не применять назальные деконгестанты **более 7 дней**; при хронических воспалительных заболеваниях носа и пазух лучше ограничиться **3 днями**.

Профилактические меры

1. отказ от курения и электронных сигарет;
2. группа риска профессионального ринита: промывания изотоническими растворами и средства индивидуальной защиты;
3. вкусовой ринит в анамнезе: отказ от пряностей и (или) алкоголя;
4. при назначении препаратов, вызывающих ринит, предупредить пациента и при появлении симптомов решить вопрос об отмене или замене;
5. функциональный подход при операциях на нижних раковинах для профилактики ятрогенного атрофического ринита.

Специфической профилактики ринита беременных, гормонального, ринита пожилых, NARES и вазомоторного ринита нет. Медицинская реабилитация не показана.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Хронический ринит»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 06.10.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее октября 2029 года
Код в рубрикаторе	`1082_1` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Национальная ассоциация ринохирургов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.